

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת  
משה אבוטבול  
מיכאל מלכיאלי  
יוסף טייב  
אברהם בצלאל  
יעקב מרגי  
אוריאל בוסו

פ/25/286

### הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – אשפוז בית), התשפ"ג–2022

תיקון התוספת 1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994<sup>1</sup>, בתוספת השנייה, אחרי פרט 2 השנייה יבוא:

"2א. אשפוז ביתי – לאבחון וטיפול."

## דבר הסבר

מוצע לעגן בחקיקה את נושא האשפוז הביתי.

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 קובע כי אשפוז בבית חולים ממומן על ידי קופות החולים כחלק מסל הבריאות. אשפוז בבית חולים הינו החלופה העיקרית כיום למקרים המצדיקים השגחה רפואית על בסיס יומי. עם זאת, לאשפוז בבית חולים חסרונות בריאותיים, נפשיים וכלכליים. ראשית, השעות בבית חולים עלולה להיות מסוכנת לחולה, מכיוון שבבית חולים מצויים חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה. בין 5% ל-10% מכלל המתאשפזים נדבקים בזיהום בבתי חולים, ובכל שנה מתים 4,000-6,000 חולים מזיהומים נרכשים בבתי חולים (מסקנות ועדת העבודה הרווחה והבריאות, 6 ביוני 2018).

נזק נוסף הנגרם משהות בבית חולים הינו נזק נפשי. חולים בבית חולים מנותקים מהסביבה המוכרת להם, פרטיותם מופרת והם חשופים לרעש ולסיטואציות קשות. לעיתים חולים כאלה לוקים בבלבול זמני עקב האשפוז, אף אם מצבם הקוגניטיבי היה תקין. מציאות זו אינה מסייעת להחלמה תקינה ומהירה. הסדר אשפוז בית קיים כיום בארצות הברית ובמדינות נוספות, ורמת הטיפול והמעקב בחולה אינה פחותה בעקבות כך.

<sup>1</sup> ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

מוצע להכניס לסל הבריאות אפשרות של אשפוז ביתי, שלפיה יקבל החולה את הטיפול הרפואי הנחוץ לו ואת הבדיקות האבחנתיות בבית. מנגנון זה עשוי לחסוך את הנזקים הבריאותיים והנפשיים הקיימים באשפוז בבית חולים, וכן להקטין את העומס על חדרי המיון בבתי החולים, ואת עלות האשפוז לחולה. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת משה אבוטבול ומאיר כהן (פ/23/2464) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה אבוטבול וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/976).  
הצעת החוק זהה לפ/24/976 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)